

УДК: 616.351-006-07

А.Т.Айрапетян, А.О. Тананян

Медицинский институт усовершенствования врачей МГУП, Москва,
Национальный Центр Онкологии им.В.А.Фанарджяна МЗ Армении

Эффективные методы диагностики при колоректальном раке

Аннотация. В статье представлены современные данные литературы по диагностике колоректального рака, так как своевременная и правильная диагностика имеет важное значение для осуществления квалифицированного и этиотропного лечения. В настоящее время различные методы своевременной диагностики и эффективного лечения КРР широко дискутируются в научной периодике. В обзорной статье представлены литературные сведения по современным методам диагностики колоректального рака.

Ключевые слова: онкологические больные, колоректальный рак, диагностические мероприятия, своевременное выявление.

В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак (КРР) занимает второе место у женщин, уступая лишь раку молочной железы, и третье место у мужчин после рака предстательной железы и легкого. За последние годы во многих странах мира отмечен рост заболеваемости КРР. По данным ВОЗ в мире ежегодно регистрируется более полутора миллиона случаев КРР. При этом наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в экономически развитых странах – в США, в странах Западной Европы, России, странах СНГ и в других экономически развитых регионах мира. Отмечено, что у каждого третьего заболевшего КРР на момент постановки диагноза выявляются метастазы в ближайшие ткани и органы и, в первую очередь, в печень, что вызывает необходимость своевременной и ранней диагностики заболевания. Несмотря на то, что толстая кишка, особенно прямая, доступны осмотру и различным современным методам обследования и диагностики, подавляющее большинство больных, к сожалению, поступают в стационар с распространенными и осложненными формами рака, порой с уже развившимися метастазами. Одной из причин запоздалого выявления злокачественной опухоли является значительный интервал между первыми ее проявлениями и началом лечения [3, 4, 9].

В этой связи обращают на себя внимание два важных обстоятельства.

Первое - это несвоевременное обращение больных к врачам. Несмотря на достаточно яркие симптомы заболевания (примесь крови в стуле, боли в животе, нарушение опорожнения кишечника и др.), более половины больных обращаются к врачу по несколько раз, превышающие 6 мес. от появления первых признаков.

Второе - от первого обращения к врачу до выявления злокачественного новообразования проходит значительный период времени. При первичном обращении КРР устанавливают в среднем у 37% больных. Остальные больные обращаются к врачу по несколько раз, в основном, из-за неэффективности лечения, назначенного по поводу других заболеваний иного характера [2,5,7].

Основная причина несвоевременного выявления злокачественного новообразования заключается в недостаточной онкологической настороженности врачей, в том числе хирургов, которые не выполняют элементарные диагностические мероприятия. Тем не менее распознавание КРР, особенно в раннем периоде, представляет значительные трудности. Клиническая симптоматика КРР часто трактуется неправильно, в связи, с чем подавляющее большинство больных направляется на стационарное лечение с ошибочно установленным диагнозом. Из них 14-36% больных к моменту диагностики опухолевого процесса уже относятся к 3 и 4 клинической стадии заболевания [1,8,11].

В этой связи основными задачами диагностической программы при КРР являются:

1. Установление факта и локализации опухоли; установление клинической формы и морфологической структуры опухоли; выявление степени местной и отдаленной распространенности опухолевого процесса.

2. Оценка общего состояния больного; диагностика сопутствующих заболеваний и оценка функционального состояния жизненно важных органов и систем.

Решение указанных задач и является собственно диагностическим процессом в отношении КРР. Особое значение в распознавании рака прямой и ободочной кишки имеет подробно собранный анамнез, уточнение начальных клинических симптомов, последовательности и выраженности нарастания клинической картины заболевания. Всеобщее признание получило пальпаторное определение опухоли. Одним из решающих методов диагностики, посредством которого распознаётся до 80-90% всех случаев рака прямой и нижнего отрезка сигмовидной кишки, является пальцевое исследование. По данным большинства авторов, к моменту установления диагноза, опухоль удаётся прощупать более чем у 2/3 больных КРР [6,10,13].

Несмотря на значительную ценность анамнеза и объективных данных исследования больного, нередко их оказывается недостаточно для распознавания заболевания, особенно на ранних стадиях КРР. В этих случаях на помощь клиницисту приходят специальные методы исследования. Основными инструментальными методами обследования больных КРР являются рентгенологический, эндоскопический и ультразвуковой, позволяющие на современном уровне медицинских знаний диагностировать на ранних стадиях заболевания, когда опухоль ещё доступна оперативному удалению.

Эндоскопический метод исследования, разработанный еще в конце 19 века С.П. Фёдоровым (1897), в настоящее время подвергается многочисленным усовершенствованиям и модификациям является одним из основных методов исследования при КРР. Дополнительными опциями удаётся осуществить электрокоагуляцию,

биопсию и фотографирование слизистой ободочной и прямой кишки. К эндоскопическим методам исследования относятся ректороманоскопия и фиброколоноскопия. Однако ректороманоскопия не позволяет в полном объеме исследовать все отделы ободочной кишки.

В настоящее время для полного исследования ободочной кишки применяется видеофиброколоноскопия, которая завоевывает всё большее признание, что вызвано преимуществами этого метода исследования перед другими способами по эффективности результатами своевременной и точной диагностики КРР. Современные видеофиброколоноскопы, имеющие достаточно совершенную оптическую систему, делают доступным визуальный осмотр всех отделов кишки, а также позволяют осуществить забор материала для морфологической верификации диагноза, не прибегая к операции - лапаротомии. По данным ряда авторов с помощью этого метода удаётся диагностировать 92-96% рака ободочной кишки [5,8,12,15].

В некоторых случаях, из-за наличия спаек в брюшной полости, которые образуются вследствие перифокального воспаления или прорастания опухоли в окружающие органы и ткани выполнение фиброколоноскопии у больных раком ободочной кишки может оказаться затруднительным, в связи с чем информативность данного метода снижается. По всеобщему признанию клиницистов, решающим методом распознавания рака ободочной кишки является рентгенологическое исследование, благодаря которому, по данным большинства авторов, удаётся распознавать заболевание у 80-90% больных [7,9].

Среди рентгенологических методов наибольшей информативностью обладает ирригография. Исследование ободочной кишки при подозрении на опухоль чаще всего осуществляется с помощью контрастной (бариевой) клизмы. Более чувствительной методикой является ирригоскопия с двойным контрастированием, при которой в просвет толстой кишки сначала вводится бариевая взвесь, а затем исследуемый орган раздувается воздухом. Сочетание ирригоскопии с видеофиброколоноскопией является наиболее ценным диагностическим методом в распознавании опухолей ободочной кишки и наиболее надёжным способом выявления рецидивов в области кишечного анастомоза [3,6,9,11].

Всё чаще в диагностике как опухолей прямой и ободочной кишки, так и в дифференциальной диагностике механической и динамической кишечной непроходимости стали применять метод ультразвукового исследования (УЗИ). Метод УЗИ, сравнительно недавно появившийся в клинической практике, быстро совер-

шенствуется и распространяется во всех областях медицины. Данный метод широко используется как для предоперационного обследования, так и в процессе последующего наблюдения за больным, позволяя получить подробную информацию о состоянии печени и забрюшинных лимфоузлов [13, 14].

В настоящее время широкое распространение получила компьютерная томография. Рентгеновская компьютерная томография позволяет оценить размеры и местное распространение опухоли, в том числе прорастание её в прилежащие к кишке органы, а также наличие отдалённых метастазов (включая вовлечение забрюшинных и мезентериальных лимфатических узлов, а также печени). Наиболее важным методом, на современном этапе получения изображения внутренних органов является ядерно-магнитный резонанс (ЯМР). Возможность анализа анатомо-физиологических характеристик практически всех органов и систем, а также характера протекающих в них биохимических процессов, как в норме, так и при развитии злокачественных новообразований, неинвазивность исследования выдвигают ЯМР-томографию на ведущее место при исследованиях на диагностическом этапе при КРР. В последнее время из инвазивных методов большое внимание уделяется экстренной лапароскопии. Особенно в тех случаях, когда после тщательного осмотра больного с учётом рентгенологических и лабораторных данных клинический диагноз все же остаётся неясным. Однако возможности этого метода ограничены, что связано с небезопасностью его использования [5,8,14].

Поэтому, при разработке алгоритма диагностики и тактики лечения больных должны учитываться не только степень распространенности опухолевого процесса и объективная оценка общесоматического статуса, но и оценка состояния больного по шкалам объективизации иммунологического и цитокинового статуса как в предоперационном, так и в динамике послеоперационного периода, что будет способствовать значительному снижению как числа послеоперационных осложнений, так и летальности.

Заключение В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест. Поэтому своевременная и правильная диагностика имеет важное значение для осуществления квалифицированного и этиотропного лечения КРР. В настоящее время различные методы своевременной диагностики и эффективного лечения КРР широко дискутируются в научной периодике. В обзорной статье представлены литературные сведения по современным методам диагностики колоректального рака.

Список литературы

1. Бадалянц Д.А. *Метастазы и рецидивы колоректального рака: статистика, диагностика, лечение: автореф. дис. канд. мед. Наук.* - Ростов-на-Дону, 2011. - 24с.
2. Вилявин М.Ю. *Диагностика послеоперационных осложнений и оценка результатов операций на печени с помощью компьютерной томографии*//Мат. 17-международного Конгресса хирургов-гепатологов стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической гепатологии». - М., 2010. - С. 16-17.
3. Дарвин В.В. и др. *Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению метастазов колоректального рака в печень*//Мат. Пленума правления Международного общества «Ассоциация хирургов-гепатологов». - 2010. - С. 19-25.
4. Лихтер М.С., Шелыгин Ю.А., Ачкасов С.И. - *Мультидисциплинарный подход к лечению больных колоректальным раком с вовлечением орга-*

нов мочевого пузыря // Хирургия им. Н.И.Пирогова.- 2012.- № 12.- С. 34-39.

5.Патютко Ю.И. и др. - Хирургическое и комбинированное лечение больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени //Онкологическая колопроктология.- 2011.-№1.- С. 24-30.

6.Петренко К.Н. и др. Результаты РЧА при лечении колоректальных метастазов в печени // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии.- 2007.-№3.- С. 22-28.

7.Помазкин В.И. - Исследование качества жизни при лечении колоректального рака // Российский онкологический журнал.- 2010.-№5.-С. 47-49.

8.Чиссов В.И., Дарьялова С.Л. // Онкология.- М.- 2006.- 720с.

9.Alabi A. et al. - Preoperative serum levels of serum VEGF-C is associated with distant metastasis in colorectal cancer patients // Int.J. Colorectal Dis.- 2009.-№24.-P.269-274.

6.Bilchic A., Poston G., Adam R. - Prognostic Variables for Resection of Colorectal Cancer Hepatic Metastases: An Evolving Paradigm // J.Clin. Oncol. - 2008. - Vol. 26. - N 33. - P. 5320-5321.

7.Egi H., Okajama M., Hinoi T. et al. - Single-incision laparoscopic colectomy using the Gelport system for early colon cancer // Scand.J.Surg.- 2012.- № 101.- P. 16-20.

8.Gasser M. et al. - Comparative analysis of predictive biomarkers for therapeutical strategies in colorectal cancer // Ann. Surg. Oncol. - 2007. - Vol. 14, N 4. - P. 1272-1284.

9.Grundmann R.T. et al. Diagnosis and treatment of colorectal liver metastases – workflow // Zentralbl. Chir.-2008.-Vol. 133. -P.267-284.

10.Iwanicki-Caron A. et al. - Usefulness of the serum carcinoembryonic antigen kinetic for chemotherapy

monitoring in patients with unresectable metastasis of colorectal cancer // J. Clin. Oncol.-2008.-№26.-P.3681-3686.

11.Kennedy J.E. et al. High-intensity focused diagnosis ultrasound for the treatment of liver tumours // Ultrasonics. - 2004. - Vol. 42.- №9. - P.931-935.

12.Levy M., Visokai V. Tumormarkers in diagnosis staging and prognosis of colorectal carcinoma // Neoplasma. - 2008. - Vol.55, № 2. - P. 138 - 142.

13.Machi J. et al. Long-term outcome of radiofrequency diagnosis ablation for unresectable liver metastases from colorectal cancer: evaluation of prognostic factors and effectiveness in first- and second-line management // Cancer. J. - 2006.-№12. -P.318-326.

14.Pawlik T.M. Surgical margins during hepatic surgery for colorectal liver

metastases: complete diagnosis and resection not millimeters defines outcome // Ann. Surg. Oncol.- 2008.- №15(3).-P.677-679.

15.Shimizu Y. et al. Diagnosis and treatment strategy for synchronous metastases of colorectal cancer // Langenbeck's Arch. Surg.- 2007.- № 39.-P.535-538.

16.Suwa T., Sakurai J., Ohtsubo T. - Cancer be a risk factor for recurrence in stage 2 colon cancer // Tumor Biology. - 2008 - Vol.29. - P.83.

17.Tsai S., Pawlik T. Outcomes of ablation versus resection for colorectal metastases: are we comparing apples to oranges? // Ann. Surg. Oncol.-2007. -Vol. 16, N 9.-P.2422-2428.

18.Wagman L.D. More tools, new strategies: enlarging the diagnosis and therapeutic scope for the patient with liver metastases from colorectal cancer // J. Surg. Oncol.-2007.-Vol.95.-P.1-3.

Тужырым

А.Т.Айрапетян, А.О. Тананян

Дәрігерлерді жетілдіру медициналық институты
МГУПП, Мәскеу, В.А. Фанарджян атындағы Ұлттық

Онкология Орталығы

Армения республикасының денсаулық сақтау
министрлігі, Ереван

Колоректальдық әтерлілік кезіндегі тиімді диагностикалық әдістері

Мақалада колоректальдық әтерлілік ісік диагностикасындағы әдебиеттердегі жаңа мәліметтері берілген, себебі білікті және этиотроптық ем алуда уақытылы және дұрыс диагностиканың маңыздылығы жоғары. Қазіргі таңда колоректальдық әтерлілік кезінде әртүрлі уақытылы диагностикалық әдістер мен тиімді ем қолдану ғылыми тұрғыда көп жерде қолданылып келеді. Шолу мақаласында колоректальдық әтерлілігінің жаңа диагностикалық әдістерінің әдеби мәліметтері берілген.

Түйінді сөздер: онкологиялық науқастар, колоректальдық әтерлілік, диагностикалық іс-шаралар, уақытылы анықтау.

Summary

A.T. Ayrapetyan, S.A. Tananyan

Medical Institute of Postgraduate Medical MGUPP, Moscow,
National Center of Oncology im.V.A.Fanardzhyan

Ministry of Health of Armenia, Yerevan

Effective diagnostic methods for colorectal cancer

The article presents the current data in the literature on the early diagnosis of colorectal cancer, as a timely and correct diagnosis is essential for the implementation of qualified and etiotropic treatment. At present, various methods of timely diagnosis and effective treatment of colorectal cancer is widely debated in the scientific literature. In a review article presents literature data on modern methods of diagnosis of colorectal cancer.

Key words: cancer patients, colorectal cancer, diagnostic measures, early identification.